PORTADA

Abordaje fonoaudiológico en el trasplante pulmonar

Experiencia clínica y desafíos en la rehabilitación

Gabriel Salgado-Maldonado - SOCHIMI 2026

DECLARACIÓN

Declaración de interés

Sin conflictos de interés declarados con la industria.

El contenido es educativo y no representa un protocolo institucional validado.

APERTURA

Comer es mucho más que un acto fisiológico

Deglución - seguridad - autonomía - vida social

PROBLEMA

¿Ausencia de tos significa deglución segura?

NO.

27% con examen clínico aparentemente normal tuvieron hallazgos instrumentales patológicos.

Baumann et al., 2017

PROBLEMA

No es una complicación rara

52-100%: rango de frecuencias reportadas en estudios heterogéneos.

No representa una prevalencia combinada.

Kutler et al., 2026

PROBLEMA

Cuando medimos mejor, vemos más

54% con signos clínicos de aspiración.

67% con penetración profunda o aspiración instrumental.

Los métodos no son intercambiables.

Baumann et al., 2017

PROBLEMA

El mayor riesgo no siempre hace ruido

54,5%: aspiración silente no detectada clínicamente en la cohorte descrita.

La evaluación clínica aislada puede subestimar el riesgo.

Barilka et al., 2025

PROBLEMA

El trasplante cambia el perfil de seguridad

Antes: 17% con deglución insegura.

Después: 84% con deglución insegura.

Subgrupo con evaluación pre y posoperatoria (n=170).

Dallal-York et al., 2022

CONSECUENCIAS

La aspiración se traduce en daño clínico

Neumonía aspirativa: 7,2% con disfagia frente a 1,8% sin disfagia.

Asociación observacional; no establece causalidad.

Barilka et al., 2025

CONSECUENCIAS

La laringe también está en riesgo

27,3% con alteración de movilidad de pliegues vocales (107/392).

Relacionada con mayor frecuencia de deglución anormal.

Kutler et al., 2025

CONSECUENCIAS

Una trayectoria crítica, no solo una cirugía

Vía aérea: intubación, reintubación, traqueostomía.

Soporte vital: ECMO y debilidad UCI.

Laringe: sensibilidad, movilidad y tos.

Barilka 2025; Son 2026

FISIOPATOLOGÍA

Tres vías convergen en la vulnerabilidad

Lesión o disfunción laríngea.

Carga de cuidados críticos.

Descoordinación respiración-deglución.

Black et al., 2021

DECISIONES

La pregunta no es solo ¿puede tragar?

La pregunta es: ¿cómo protegemos la vía aérea y decidimos una alimentación segura?

DECISIONES

FEES y videofluoroscopia se complementan

FEES: secreciones, anatomía y movilidad laríngea, evaluación junto a cama.

VFSS: biomecánica, fase oral, tránsito y apertura esofágica superior.

Baumann 2017; Barilka 2025

DECISIONES

Antes del trasplante: establecer línea basal

Historia deglutoria, respiratoria y nutricional.

Identificar riesgo individual.

Evaluación dirigida y preparación con el equipo.

Black et al., 2025

DECISIONES

Después del trasplante: ruta propuesta

1. Estabilidad y alerta.
2. Evaluación clínica.
3. FEES o VFSS oportunas.
4. Decisión de vía oral.
5. Reevaluación y seguimiento.

DECISIONES

¿Cuándo reiniciar la vía oral?

Cuando sea razonablemente segura según la evaluación individual.

Estado respiratorio, secreciones, resultado instrumental y plan alimentario.

No hay un día posoperatorio universal.

INTERVENCIÓN

Proteger, recuperar y sostener

Compensación individualizada y soporte nutricional cuando corresponda.

Rehabilitación según mecanismo.

Higiene oral, educación y reevaluación.

INTERVENCIÓN

Terapia orientada por el mecanismo

Alteración de cierre: valoración laríngea y protección.

Residuo: estrategias y ejercicios seleccionados.

Tos: intervención respiratoria apropiada.

Coordinación: abordaje aerodigestivo.

INTERDISCIPLINA

La deglución segura es un trabajo en equipo

Fonoaudiología - Neumología y cirugía torácica - ORL.

Nutrición - Enfermería - Kinesiología - Terapia ocupacional.

EVOLUCIÓN

Recuperar la ingesta es posible

35,9% con disfagia funcional en POD 28.

87,1% con ingesta oral funcional al alta.

FOIS describe función; no descarta aspiración.

Son et al., 2026; n=124

COMENSALIDAD

Volver a comer también es volver a compartir

36% evita comer con otros; 41% reporta ansiedad en las comidas (disfagia diversa).

24,7% de trasplantados recibió alta con dieta modificada.

La comensalidad no se ha medido suficientemente tras trasplante.

Ekberg 2002; Barilka 2025

EVOLUCIÓN

Disfagia persistente: posible señal de vulnerabilidad

35,9% con FOIS <=3 en día 28.

87,1% con FOIS >=4 al alta.

Supervivencia a 1 y 2 años menor en el grupo con disfagia, p<0,01.

Asociación no ajustada; no demuestra causalidad.

Son et al., 2026; n=124

EVIDENCIA

Lo que sabemos y lo que falta demostrar

Frecuencia elevada y aspiración silente.

Aún no hay un protocolo universal óptimo.

Efectividad específica de intervenciones y desenlaces del injerto siguen siendo preguntas abiertas.

Kutler 2026; Black 2020

DESAFÍOS

Cuatro desafíos de implementación

Acceso oportuno a FEES o VFSS.

Criterios comunes.

Continuidad tras el alta.

Resultados clínicos, funcionales y participación social.

Black et al., 2025

CIERRE

Tres decisiones que pueden cambiar la práctica

No asumir seguridad solo por ausencia de tos.

Buscar fisiopatología, no solo la etiqueta.

Medir recuperación y trabajar como equipo aerodigestivo.

MENSAJE FINAL

Un injerto puede respirar. Nuestra tarea es ayudar a protegerlo.

La deglución segura también forma parte del cuidado del trasplante.

SOCHIMI 2026 - Universidad de los Andes